جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ليلى احمد محمد دسوقى

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اوسيم **العنوان :** --

رقم البطاقة : 25703212100981 **رقم التليفون :** 01021576913 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 21-03-1957 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(---------------------------) **التوقيع:(---------------------------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ---------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** --------------------------- **التوقيع:** د/محمد كيلاني ---------------------------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** --------------------------- **التوقيع:** د/ندى حسن ---------------------------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** --------------------------- **التوقيع:** نرمين رمضان ---------------------------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ----------------------- **ا.د/** ----------------------- **د/** ----------------------- **د/** -----------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --

خطة العلاج : --

المستشفي : --- **قسم :** ---

جهة العلاج : --- **نفقات :** ---

ملاحظات : --

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: ليلى احمد محمد دسوقي
National ID: 25703212100981

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

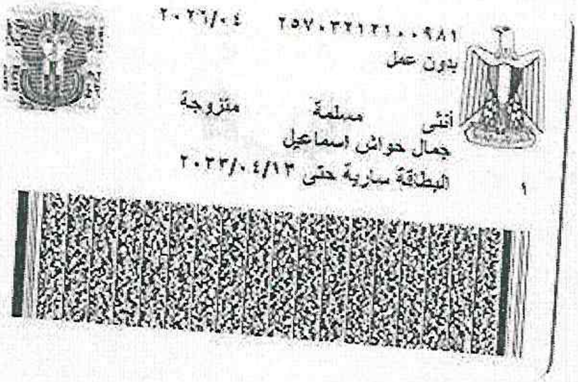
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٥٧٠٣٢١٢١٠٠٩٨١ ٢٠٢٦/٠٤

بدون عمل

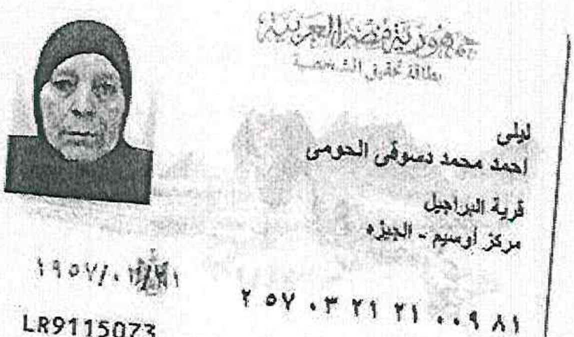
أنثى مسلمة متزوجة

جمال حواش اسماعيل

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٤/١٣

٠١٠٢١٥٧٦٩١٣

٠١١١٠١٩[illegible]٦١



جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية

ليلى

احمد محمد دسوقى الحومى

قرية البراجيل

مركز أوسيم - الجيزه

١٩٥٧/٠١/٢١

٢ ٥٧ ٠٣ ٢١ ٢١ ٠٠٩ ٨١

LR9115073

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name: Laila Ahmed Mohammed Desoky	Date: 2026-09-08
Exam: Ultrasound ABDOMEN& PELVIS	

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *Mild enlarged sized (17cm at Rt MCL)homogenous parenchymal echo pattern .*
- *No IHBRD seen*
- *Portal vein is patent and not dilated.*

Gall Bladder: -

Average size, no stone and no masses. Patent CBD and not dilated.

Spleen: -

- *Normal size 12 cm, homogenous texture with no focal lesions*

- **Kidneys: -**
  - *Both kidneys of normal size, shape, normal echogenicity and well differentiated with good corticomedullary differentiation.*
  - *No stones , no back pressure changes*

Peritoneal deposits detected.

Urinary Bladder: -

- *No stones or Masses.*
- ***No pelvic masses detected by ultrasound.***
- ***Marked ascites.***

Opinion:

Marked ascites with diffuse peritoneal deposits for correlation with previous imaging data.

Mild hepatomegaly.

Dr. Dalia Adel

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

Name: ليلى احمد محمد دسوقى

MR. : 11407

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من

بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :

تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient presented with abdominal pain and constipation, and imaging in April 2026 revealed moderate ascites with irregular mural thickness of the transverse colon and splenic flexure measuring 11 mm. Colonoscopy demonstrated moderate internal piles. Ascitic fluid cytology was positive for malignancy, with tumor markers CA125 = 868, CA19-9 = 11.3, and CEA = 1.9. A PET-CT performed in mid-August 2026 showed metabolically active bilateral ovarian lesions with omental-peritoneal thickening and scattered abdominal lymph nodes, consistent with a primary ovarian neoplasm and metastatic deposits. Ascitic fluid biopsy confirmed malignant cells. The multidisciplinary team discussed options of surgery versus neoadjuvant chemotherapy.

In early September 2026, the patient was staged as stage 3 ovarian cancer. PET-CT documented bilateral ovarian masses with multiple peritoneal and omental deposits (SUV 9.2) and low-grade abdominal lymph nodes (SUV 1.7). Ascitic fluid cytology remained positive for malignant cells. The patient was BRCA-1/2 negative. A treatment plan of 9 weeks of taxane-carboplatin (taxol 135 mg/m^2, carboplatin AUC 2) was initiated, with subsequent imaging or PET-CT and referral for surgery. The patient weighed 93 kg, height 160 cm, dry weight 79 kg, serum albumin 1.87 g/dL, and creatinine 1.56 mg/dL. Week 1 of therapy included taxol and carboplatin, with weight reassessment and creatinine monitoring next week, and evaluation of marked ascites.

During week 2 of therapy, the patient attended for follow-up. Laboratory values were: TLC 3.59 × 10^9/L, 2.32 × 10^9/L, creatinine 1.65 mg/dL, AST 41 U/L. The patient had marked ascites but was not in distress. A PAUS was ordered to assess the ascites and consider possible tapping. The patient has completed 2 weeks of taxol/carbo.

تحريرا في ,

التاريخ : 19-09-2026

الوقت :

الطبيب المعالج : mohamed ismael

يعتمد ,